1 A

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Este pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno (a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	PAULA DUELLEO FERRADA.				Sexo	F ✗	M
Fecha Nacimiento	28-01-2020	Edad actual	4 años	3 meses	País natal:	Chile	
Domicilio actual:	CALLE LAURA PONCE. SECTOR LOS ANDES			Teléfono	999799006		
Lengua materna	CASTELLANO	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☐ escribe ☐ Poco				
Lengua de uso	CASTELLANO	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☐ escribe ☐ Poco.				
Escolaridad actual:	PK.	Establecimiento	Liceo Mixto Los Andes Básico N°1				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 02-04-24	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: AIDA FERRADA	Nombre:
Relación con el/la estudiante: MADRE.	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 02-04-2024	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: PAULA CRISOSTOLO C.	Nombre:
Rol/cargo: COORD. PIE.	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

- DIFICULTADES EN LENGUAJE.
- SUSTITUYE FONEMAS - ARTICULA - INCONSISTENTE - OMITE.

* ESTUVO EN SALA DE ESTIMULACIÓN (4 SESIONES) 2022 *

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☑ Sí (especificar)

Pediatría:	—		
Kinesiología:	—	Psicología:	—
		Psiquiatría:	—

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología: TRASTORNO DEL LENGUAJE	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☒ cesárea (señalar motivo) DECISIÓN PERSONAL.

¿Tuvo asistencia médica durante el parto? ☒ SI ☐ NO | Peso: 2,800 KGS. | Talla: 40 cm.

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

- PLACENTA PREVIA.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	~~Sí~~	No	Traumatismos	Sí	~~No~~	Encefalitis	Sí	~~No~~
Obesidad	Sí	~~No~~	Intoxicación	Sí	~~No~~	Meningitis	Sí	~~No~~
Fiebre alta	Sí	~~No~~	Enfermedad respiratoria	~~Sí~~	No	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	~~No~~	Asma	Sí	~~No~~			
Hospitalizaciones	Sí	~~No~~	Especifique motivos y duración: —					

Se realizaron controles periódicos de salud	~~Sí~~	No	Vacunas	~~Sí~~	No

Observaciones:

- Después de los 6 meses (problemas con la alimentación) BAJO PESO *

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 2-3 aprox.	Se sienta sólo/a: 6 meses	Camina sin apoyo: 1 a 3 m
Primeras palabras: 1 a 1/2	Primeras frases: 2 a APP.	Se viste solo/a: AÚN NO.
Controla esfínter vesical Diurno: ✓ Nocturno: ✓	Controla esfínter anal Diurno: ✓ Nocturno: ✓	

Observaciones:

—

En su actividad motora general se aprecia: ☑ normal ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo	**Su tono muscular general se aprecia:** ☑ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~Sí~~	No	Caídas frecuentes	Sí	~~No~~	Dominancia lateral	~~Sí~~	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~Sí~~	No	Prensión	~~Sí~~	No	Pinza	~~Sí~~	No
Ensarta	~~Sí~~	No	Dibuja	~~Sí~~	No	Escribe	Sí	~~No~~

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Sí~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Sí~~	No
Demanda objetos y compañía	~~Sí~~	No	Comprende prohibiciones	~~Sí~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Sí~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Sí	~~No~~

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Observaciones: Si le interesa algo lo hace sin dificultad.

5.3. Visión - Audición:					
Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No

Observaciones: Se entiende cuando se comunica (madre). Problemas al expresarse. Se frustra cuando no logra.

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☐ oral ☐ gestual ☑ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No +-
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No +-
Comprende conceptos abstractos +-	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): NO *

Observaciones:
Sin pérdida del lenguaje.
Si Alterado.

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No A veces.
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No

3

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Opta por trabajo individual	~~Sí~~	No	Muestra sentido del humor	~~Sí~~	No
Presenta lenguaje ecolálico (repite palabras, silabas, etc.)	Sí	~~No~~	Movimientos estereotipados (repetitivos)	Sí	~~No~~
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas +−	Sí	~~No~~	Pataletas frecuentes	Sí	~~No~~

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	**Sonidos:**	**Personas extrañas:**
☑ natural ☐ desmesurada	☑ natural ☐ desmesurada	☐ natural ☑ desmesurada

Observaciones: no se acerca a personas adultas que no conoce.

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	~~Sí~~	No	Trastorno motor	Sí	~~No~~
Epilepsia	Sí	~~No~~	Problema bronco-respiratorio	~~Sí~~	No
Problemas cardiacos	Sí	~~No~~	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	~~No~~
Paraplejia	Sí	~~No~~	Trastorno emocional	Sí	~~No~~
Pérdida auditiva	Sí	~~No~~	Trastorno conductual	Sí	~~No~~
Pérdida visual	Sí	~~No~~	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique): Sí /

Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☑ Otro (especifique) Mas o menos

Peso (apreciación del informante): ☑ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☑ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 9 aprr.

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos ☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor. Solo.

Duerme: ☐ solo ☐ acompañado (Especifique): papá y mamá. (Situación pasada)

Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***

☑ alegre ☐ juguetón/bromista ☑ risueño(a) ☑ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)

Otro:

Observaciones:

Hay algunas comidas que no come (Arvejas).

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Nacho Pueller	Papá	37	Superior	trabaja en el campo
2. Belen Pueller	Mamá	9	Básico.	Estudiante.
3. Fernanda Astañeda	Abuela	72	Básica.	Dueña de casa
4. Aixa Ferreda	Tía	32	Superior	Asist. párvulos.
5.				
6.				
7.				
8.				

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

- PAPÁ epilepsia en TTO. (remitido).
- PAPÁ resistencia a la insulina (TTO.).
- Anula cálculo a la vesícula (TTO.) – Operación.

Observaciones: —

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	4 a	Asistió a jardín infantil	✓ Sí	No
N° de colegios en que ha estudiado	1	Modalidad de enseñanza Regular ✓ Especial ☐ Técnica ☐:		

Motivo de los cambios: —

Ha repetido curso/s	Sí	No ✓	Curso(s)	Motivo:

Situación actual

Nivel/curso actual	PKA		Dificultad de aprendizaje	Sí	~~No~~ =	Dificultad para participar	Sí	No ✓	Conducta disruptiva	Sí	No ✓
Asiste regularmente	Sí ✓	No	Asiste con agrado	Sí ✓	No	Apoyo familiar en tareas	Sí ✓	No	Amigos (as)	Sí ✓	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
✓ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
✓ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
✓ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra ..... Felicitación.

Especifique el tipo de refuerzos o premios:
✓ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ✓ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
✓ madre ✓ padre ✓ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
✓ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
✓ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

5

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY